

Hémoglobinopathie rare de type hémoglobine Lepore : à propos d'un cas pédiatrique familial

G. BOURZOUZOU¹, N. BOUTRID¹

¹ Service de pédiatrie, EHS El Eulma, Sétif

INTRODUCTION

Les hémoglobinopathies de type Hb Lepore sont des anomalies génétiques rares résultant d'un crossing-over inégal entre les gènes δ et β de la globine. Elles associent des caractéristiques des β -thalassémies et des variants structuraux de l'hémoglobine, avec une expression clinique variable allant de formes asymptomatiques à des tableaux de thalassémie intermédiaire. Leur diagnostic reste parfois difficile et repose sur des explorations spécialisées.

RÉSULTATS

L'examen clinique retrouvait une pâleur cutanéomuqueuse modérée sans hépatosplénomégalie ni altération de l'état général, avec une croissance staturo-pondérale conservée. Le bilan biologique objectivait une anémie microcytaire hypochrome modérée avec un taux d'hémoglobine à 10,2 g/dL et une ferritine normale, éliminant une carence martiale. L'électrophorèse de l'hémoglobine montrait un profil compatible avec une Hb Lepore. L'étude familiale retrouvait une anomalie similaire chez la mère, confirmant le caractère héréditaire de l'affection.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Il s'agit d'une observation clinique d'une fillette âgée de 3 ans, adressée pour exploration étiologique d'une anémie chronique. L'évaluation a comporté un examen clinique complet, un bilan biologique standard incluant l'hémoграмme et le bilan martial, ainsi qu'une électrophorèse de l'hémoglobine. Une enquête familiale a été réalisée afin de rechercher une anomalie héréditaire.

CONCLUSION

L'Hb Lepore est une hémoglobinopathie rare dont le diagnostic repose sur l'électrophorèse de l'hémoglobine, éventuellement complétée par des techniques de biologie moléculaire. Sa reconnaissance est essentielle afin d'éviter les erreurs diagnostiques avec les thalassémies et d'adapter la prise en charge. Le dépistage familial systématique est indispensable pour le conseil génétique et une prise en charge précoce.